SDD 277 Sujet n°1

Spécialité : Rhumatologie

Date : 23/10/2024
Auteures : Eloïse FOIRET (DES allergologie, EN 2024), Camille MARTINAUD (DES psychiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2024), Valentin BRARD (DES médecine générale, ECN 2023), Clément FILLIOL (DES RAI, ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen physique
Item(s) en lien avec la station	Item 94 - Rachialgie
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 277 - Consultation de suivi d'un patient présentant une lombalgie aiguë ou chronique
Matériel nécessaire à la station	Une table, deux chaises
Contexte de la station	Consultation de médecine générale en ville

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste et vous recevez Mme C., 27 ans, pour une douleur lombaire basse apparue il y a 2 semaines.
La patiente a déjà consulté un autre médecin généraliste il y a 2 semaines, qui lui a prescrit du paracétamol et de l'ibuprofène.
La persistance de la douleur inquiète Mme C, qui vous consulte dans ce contexte.

Consignes :
Au cours de cette station, vous devrez en 8 minutes :

- Recueillir les données nécessaires auprès de la patiente afin de caractériser sa plainte
- Réaliser l'examen clinique ciblé de la patiente

Vous ne réaliserez pas l'examen physique sur le patient standardisé mais vous décrirez ce que vous recherchez à l'examinateur.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	**Caractérise la douleur** : type, trajet, intensité, horaire, facteur aggravant, facteur améliorant, évolution, association à une radiculalgie (*4 éléments au moins pour avoir le point*)	1 pt	☐
2.	Recherche le **facteur déclenchant.**	1 pt	☐
3.	Évalue l'intensité de la douleur par une échelle numérique.	1 pt	☐
4.	Recherche : - une **fièvre** - <u>ou</u> une **altération de l'état général** (asthénie ET anorexie ET amaigrissement) (*1 élément sur 2 pour avoir le point)*	1 pt	☐
5.	Recherche les facteurs de risque de **chronicisation** *(au moins 1 élément sur les 4)* : - Anxiété - Dépression - Souffrance au travail - Isolement	1 pt	☐
6.	Recherche d'au moins un signe étiologique parmi - signe de la sonnette - syndrome rachidien (contracture para-vertébrale)	1 pt	☐
7.	Recherche d'au moins un signe de radiculopathie : - signe de Lasègue - signe de Léri.	1 pt	☐
8.	Recherche un **déficit moteur** au niveau des membres inférieurs pour chaque groupe musculaire.	1 pt	☐
9	Recherche une **abolition** des **réflexes ostéo-tendineux** aux 2 membres inférieurs.	1 pt	☐
10.	Évalue la **marche** : - Sur les talons - Sur la pointe des pieds	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Communications et attitudes

11.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

12.

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

13.

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

14.

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TOTAL	14 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Eléments de rétroaction :
En consultation de médecine générale, les lombalgies sont plus souvent de causes **primaires** (hernie discale, arthrose, canal lombaire rétréci) que secondaires (traumatisme, spondylodiscite, cancer, cause extra-rachidienne etc).

L'anamnèse doit donc être focalisée sur les points suivants :

1. **Eliminer une cause secondaire** = recherche des **drapeaux rouges** (cf. recommandations de la HAS sur la lombalgie) :
    a. Age < 20 ou > 50 ans, antécédent de cancer, corticothérapie
    b. Usage de drogues intraveineuses (risque d'infections cutanées puis bactériémie à staphylocoques)
    c. Contexte de traumatisme violent
    d. Fièvre, altération de l'état général, perte de poids inexpliquée
    e. Douleur thoracique, inflammatoire
    f. Symptômes neurologiques étendus, paresthésie du périnée (recherche d'une urgence neurologique : compression médullaire/syndrome de la queue de cheval)
2. **Caractériser la douleur** (LITHIASE : Localisation, Irradiation, Type de douleur, Horaires, Intensité, facteurs Aggravants et Améliorants dont la médication, Signes associées, Evolution) :
    a. Hernie discale : favorisée par les traumatismes/effort, douleur médiane augmentée à la toux
    b. Arthrosique : douleur augmentée à l'hyperextension/procubitus et diminuant l'antéflexion
3. Rechercher le **retentissement** : essentiel pour toute douleur, en particulier celles subaiguës/chroniques.

L'examen clinique reprend en réalité les deux premiers points ci-dessus :

1. **Inspection** : déformation sagittale ou frontale, attitude antalgique
2. **Palpation** des **processus épineux** à la recherche d'un point douloureux/signe de la sonnette, et des masses musculaires (contracture)
3. **Mobilisation** : distance doigt-sol, indice de Schöber et inclinaisons latérales → recherche d'une raideur
4. Examen **neurologique** des membres inférieurs (dont la marche !) à la recherche :
    a. d'une compression médullaire/syndrome de la queue de cheval (examen sensitivo-moteur, ROT +)
    b. d'une radiculalgie (signe de Léri/Lasègue)

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes Mme C., vous vous présentez au cabinet pour une douleur au dos qui ne passe pas depuis 2 semaines.
Vous avez déjà consulté un médecin généraliste il y a 2 semaines pour cette même douleur. Il vous a prescrit du paracétamol et de l'ibuprofène, mais la douleur persiste.

Plan de la station ECOS :

La patiente est en face du médecin, assise devant une table.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, je viens vous voir parce que j'ai mal au dos depuis 2 semaines et ça ne passe pas.

Identité du patient :

Mme C., 27 ans
1.70 m, 65 kg

Mode de vie :

Vit chez ses grands-parents, bien entourée
Agente immobilière
Pas d'intoxication alcoolo-tabagique, ni aux drogues
Fait du volley-ball 2 fois par semaine

Comportement global :

Anxieuse, légèrement déprimée
Souhaite reprendre rapidement le travail

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Antécédents personnels :

Dépression sévère à 25 ans

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

PARACÉTAMOL et IBUPROFÈNE pour les douleurs SERTRALINE 150 mg 1x/j

Symptômes positifs :

- 1 épisode de douleur apparue il y a 2 semaines en déplaçant une pierre pour aider ses parents à construire un muret :
  - Localisation : lombaire
  - Irradiation : dans le dos, et face postérieure de cuisse droite
  - Type : difficile à décrire
  - Horaires : prédominant en fin de journée et après effort, pas de réveils nocturnes
  - Intensité : EN 5/10
  - Aggravée à la toux
  - Améliorée en position allongée
  - Pas d'amélioration significative après prise de PARACÉTAMOL/IBUPROFÈNE (EN restant constante à 5/10)
  - Evolution : stable depuis 2 semaines
- Pas de fièvre
- Pas d'asthénie, pas d'anorexie, pas d'amaigrissement
- Pas de troubles de la marche
- Pas de sensation de faiblesse des membres inférieurs
- Pas de troubles urinaires, digestifs ou sexuels

<u>Conséquences psychosociales :</u>
- Pas d'arrêt de travail (car il y a trop de travail à faire dans l'agence en ce moment)
- Limitation des activités physiques (pas de volleyball)
- Pas d'isolement social

Questions de relance :

0

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)